



EXTENSIVO BASES
Material de Acompanhamento

SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

George Carvalho



Objetivos da Aula

1. Aprender o PALM-COEIN;
2. Aprender sobre as causas de SUA não-estrutural;
3. Aprender sobre Pólipos;
4. Aprender sobre Adenomiose;
5. Aprender sobre Leiomiomatose;
6. Aprender sobre sangramento pós-menopausa e biópsia endometrial;
7. Aprender o manejo do SUA na urgência.



Caso Clínico

- Adriana, 36 anos, G2P2 (PN), procurou ajuda no posto de saúde porque a sua menstruação está muito intensa e com muitas cólicas há 3 anos. Refere que antes ficava 4 dias menstruada e que hoje chega a ficar 15 dias e precisa usar fralda, às vezes. Relata também que está achando a sua barriga maior. Ao exame físico, vulva sem alterações, colo e vagina também sem alterações. O toque vaginal evidenciou um colo ginecológico, móvel e indolor e um útero palpável 5 cm acima da sínfise púbica, de consistência endurecida, superfície irregular e móvel.
- Dentro do mnemônico PALM-COEIN, a provável causa da SUA de Maria José é estrutural ou não-estrutural?
- Qual o primeiro exame que devemos solicitar para iniciar a investigação da causa da SUA em Maria José?
- Sendo a causa estrutural a mais provável, qual é a principal hipótese de diagnóstico?



Canva.com



SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

1 CICLO MENSTRUAL NORMAL

VARIAÇÃO	24 a 38 dias	→ 21 a 35 dias
DURAÇÃO	Até 8 dias	
REGULARIDADE	Variação entre os ciclos < 9 dias	
VOLUME	Variação entre os ciclos < 9 dias	

2 SUA

“EXCLUIR GESTAÇÃO”

“São alterações da menstruação decorrentes de aumento no volume, na duração ou na frequência”.
(Sangramento uterino anormal, febrasgo, 2017/2018)

“Perda menstrual excessiva, com repercussões físicas, emocionais, sociais e materiais na qualidade de vida da mulher”



3 SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

Sangramento uterino anormal (SUA)

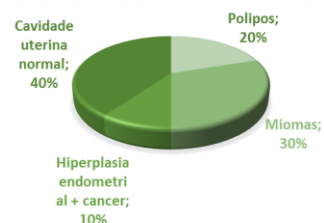
CAUSAS ESTRUTURAIS

- **PÓLIPO**
- **ADENOMIOSE**
- **LEIOMIOMA**
- **MALIGNAS**

CAUSAS NÃO ESTRUTURAIS

- **COAGULOPATIA**
- **OVULATÓRIA**
- **ENDOMETRIAL**
- **IATROGÊNICA**
- **NÃO CLASSIFICADA**

CAUSAS DE SUA DE 30 A 50 ANOS



Adaptado: ESHRE, Human Reproduction Update 2007, 13(5): 421-431.
Classificação do sangramento uterino anormal de acordo com a Federação internacional de ginecologia e obstetria (Figo), 2011.
<https://pt.slideshare.net/ClaudioBonduki/tratamentodosangramentouterinoanormal-130704091433phpapp01>



4 CAUSAS NÃO ESTRUTURAIS

COAGULOPATIAS

Doença de Von Willebrand

OVULATÓRIAS

Extremos de idade

SOLICITAR

- Hemograma
- Ferritina sérica
- TSH
- Coagulograma
- Fibrinogênio
- Atividade e antígeno do fator de Von Willebrand
- Atividade do fator VIII

CAUSAS

- Imaturidade de eixo HHO
- SOP
- Hipotireoidismo
- Hiperprolactinemia
- Anorexia
- Exercícios físicos extenuantes
- Perda de peso

ENDOMETRIAIS

Endometrite e Disfunção da hemostasia local
Endometrial

IATROGÊNICA

Anticoncepcionais hormonais, DIU
Anticoagulantes, lesões traumáticas

NÃO-CLASSIFICADA

MAV, Istmocele...



Vou Gabaritar na Residência

1. (HOS-SP 2025 ACESSO DIRETO) – Adolescente de 18 anos de idade, sexo feminino, ciclos menstruais regulares, DUM: há 10 dias, MAC: DIU de cobre, sem comorbidades. Deu entrada no pronto-socorro ginecológico com sangramento vaginal em grande quantidade. Atividade sexual recente. Nega episódio semelhante prévio. Nega dor tipo cólica. PA = 90 x 50 mmHg, FC = 105 bpm, TAX = 36 graus Celsius. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta e o diagnóstico mais provável.
- A. Ultrassom transvaginal; torção ovariana.
 - B. Beta HCG quantitativo; gestação ectópica rota.
 - C. Beta HCG quantitativo; gestação molar.
 - D. Toque vaginal; abortamento em curso.
 - E. Exame especular; laceração vaginal.

CAUSAS ESTRUTURAIS – CAUSAS ESTRUTURAIS PÓLIPO

5 CAUSAS ESTRUTURAIS

5.1 PÓLIPO

ENDOMETRIAIS



CERVICAIS

Endocervicais



Ectocervicais



<https://screening.iarc.fr/atlasviadetail.php?Index=41&e=>
<https://clinicaalmeidaasencio.com.br/noticia/polipo>
<https://www.sciencephoto.com/media/459289/view/cervical-polyp>



5.2 PÓLIPO CERVICAL

CLÍNICA	DIAGNÓSTICO	TRATAMENTO	
Assintomático	Exame Especular	Expectante	1,5%
SUA			• Sintomático • $\geq 3cm$ • Atípico
Sinusiorragia	Histeroscopia (padrão-ouro)	Remoção em consultório	
Infertilidade		Histeroscopia Cirúrgica	

5.3 PÓLIPO ENDOMETRIAL

PRÉ-MENOPAUSA	MALIGNIZAÇÃO
PÓS-MENOPAUSA	0,5-3%

FATORES DE RISCO

Menopausa + SUA	DM
> 1 cm	Obesidade
HASC	Uso de tamoxifeno



6 PÓLIPOS ENDOMETRIAIS

6.1 CLÍNICA

Assintomático

Infertilidade

Sinusiorragia

SUA

Lesões
pré-malignas/
Malignas

Sangramento
pós-menopausa

Aumento do fluxo menstrual

Sangramento intermenstrual

6.2 ETIOLOGIA

Fibrosos

Atróficos

Funcionais/Mucosos

Semelhantes ao endométrio
normal

Adenomatosos

Músculo liso

Hiperplásicos

Hiperplasia com ou sem atipia

“Projeções da mucosa endometrial”



6.3 DIAGNÓSTICO

USG-TV

HISTEROSSALPINGOGRAFIA

HISTEROSSONOGRRAFIA

HISTEROSCOPIA

PADRÃO-OURO

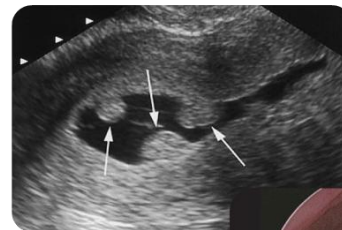
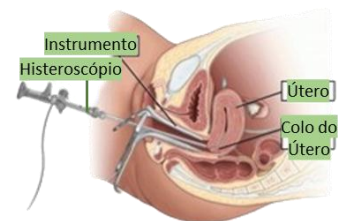
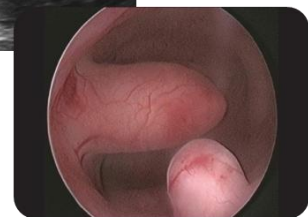


Imagem
Hiperecoica



<http://www.vidabemvinda.com.br/blog/polipo-endometrial-e-fertilizacao-in-vitro/>

<https://www.fetalmed.net/como-se-trata-um-polipo-endometrial/>

<https://www.tuasaude.com/histeroscopia/>

6.4 TRATAMENTO

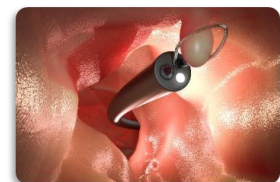
MENACME

- Expectante
- Histeroscopia cirúrgica



MENOPAUSA

Histeroscopia Cirúrgica



- Assintomático
- < 1cm
- Sem FR para malignizar (HASC, DM, obesidade, tamoxifeno)

<https://ayrozaribeiro.com.br/materias/polipo-endocervical/>

<https://paulajoaquim.com.br/polipo-endometrial>



Vou Gabaritar na Residência

2. (ENARE 2025 R4 GO) – Uma paciente de 45, gesta 2 para 2 (partos vaginais), relata ao(à) ginecologista que não faz uso de método contraceptivo, pois o marido fez vasectomia. Tem dislipidemia e hipertensão arterial, ambas bem controladas com medicação e estilo de vida. A última colpocitologia oncótica foi realizada há 8 meses, com resultado normal. Refere que há 6 meses notou aumento do fluxo menstrual, sangramento intermenstrual e após relação sexual. A avaliação inicial e hipótese principal devem ser, respectivamente:
- A. Colpocitologia oncótica e lesão de alto grau no colo uterino.
 - B. Ultrassonografia transvaginal e mioma subseroso.
 - C. Ultrassonografia transvaginal e pólio endometrial.
 - D. Histeroscopia e atrofia endometrial.
 - E. Ressonância nuclear magnética de pelve e endometriose.

CAUSAS ESTRUTURAIS ADENOMIOSE

7 CAUSAS ESTRUTURAIS

7.1 ADENOMIOSE



“Invasão **benigna** do endométrio no miométrio além de 2,5mm de profundidade, ou, no mínimo, um campo microscópico de grande aumento, distante da camada basal do endométrio, com presença de **GLÂNDULAS E ESTROMA** endometriais”, circundados por hiperplasia e hipertrofia das células miometriais.”

<https://saudebrasil.com.br/ginecologia/entenda-o-que-e-adenomiose-seus-sintomas-e-tratamento/>



7.2 ADENOMIOSE

FATORES DE RISCO

40-50 anos

Uso de contraceptivos
hormonais

> 2 gestações

Menarca < 10 anos

Uso de Tamoxifeno

Abortamentos prévios

Ciclos menstruais
< 24 dias

Obesidade

Cirurgias uterinas
prévias

8 ADENOMIOSE

8.1 ETIOPATOGENIA





8.2 SINAIS E SINTOMAS

Assintomático

Aumento do volume uterino

Sangramento aumentado na menstruação

Infertilidade

Dismenorreia

Associação com outras patologias (mioma, endometriose, pólio endometrial)

8.3 EXAME FÍSICO

Útero aumentado

Útero doloroso à mobilização

Nódulos adenomióticos

Irregular

Não grande demais



ADENOMIOSE



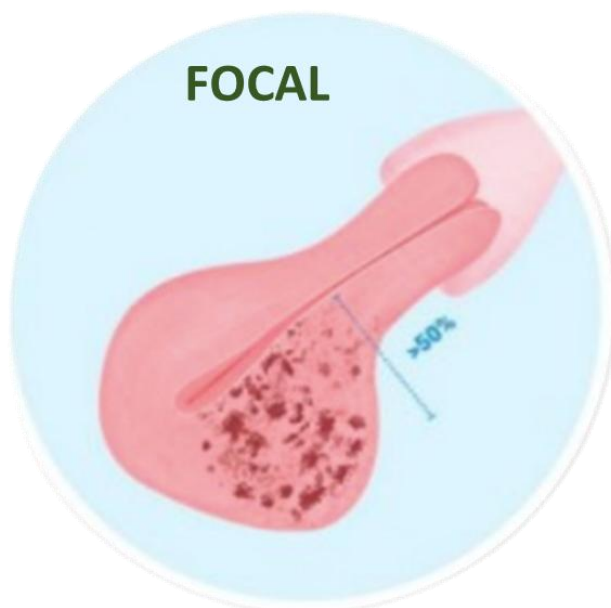
**NÓDULOS
ADENOMIÓTICOS**

Forma difusa

Forma focal

Mais comum

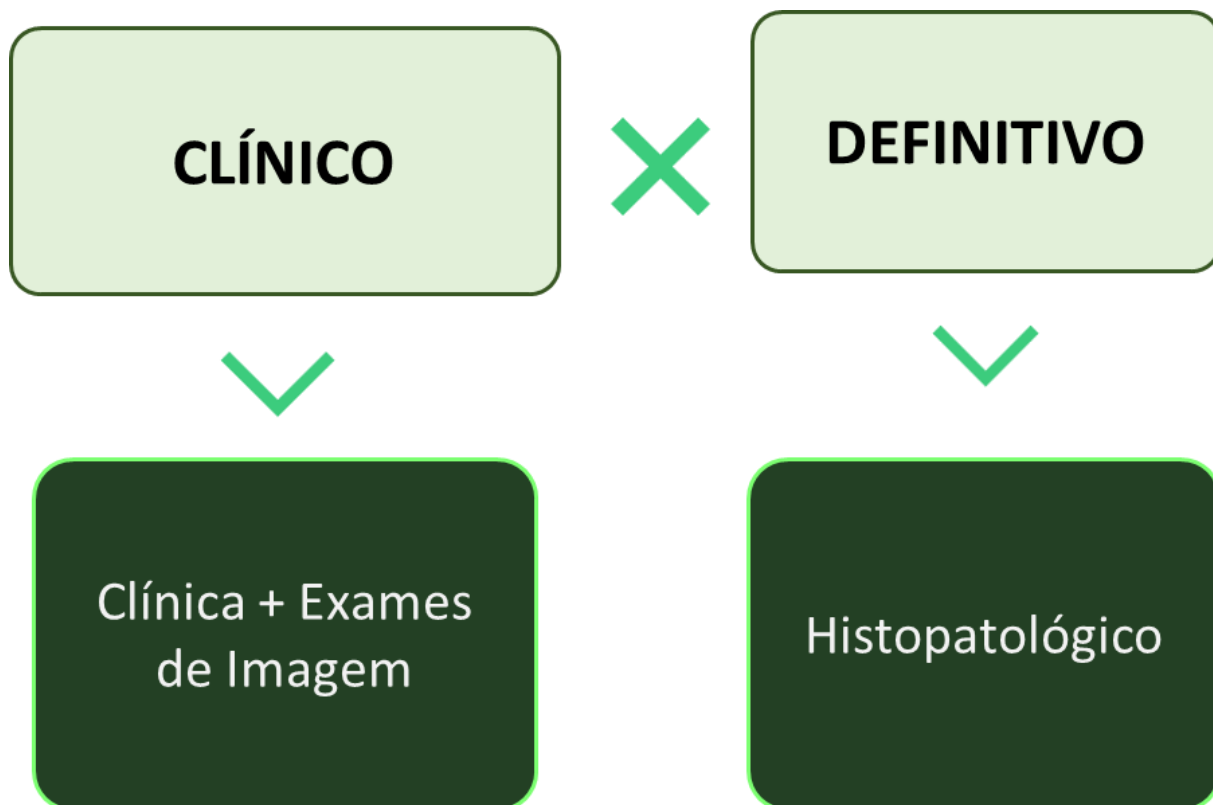
**Massa miometrial com
margens, com sinal de baixa
intensidade em todas as
sequências da RNM**



<https://ipgo.com.br/adenomiose-completo/>

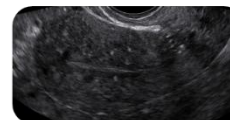


8.4 DIAGNÓSTICO



USG-TV

- Formato globoso/regular
- Paredes uterinas assimétricas
- Heterogeneidade difusa ou focal no miométrio
- Cistos anecóicos no miométrios
- Estrias ecogênicas radiadas partindo do endométrio
- Zona juncional mal definida



RNM

- Zona Juncional > 12mm
- Focos de alta intensidade da zona juncional

HISTEROSCOPIA



<https://drpixel.fcm.unicamp.br/conteudo/aspectos-ultrasonograficos-da-adeniose>

<https://drpixel.fcm.unicamp.br/conteudo/aspectos-ultrasonograficos-da-adeniose>

<https://diagnosis.com.br/servicos-ultrassom/ultrassom-ginecologico/>

<https://fipgo.com.br/adeniose-completo/>

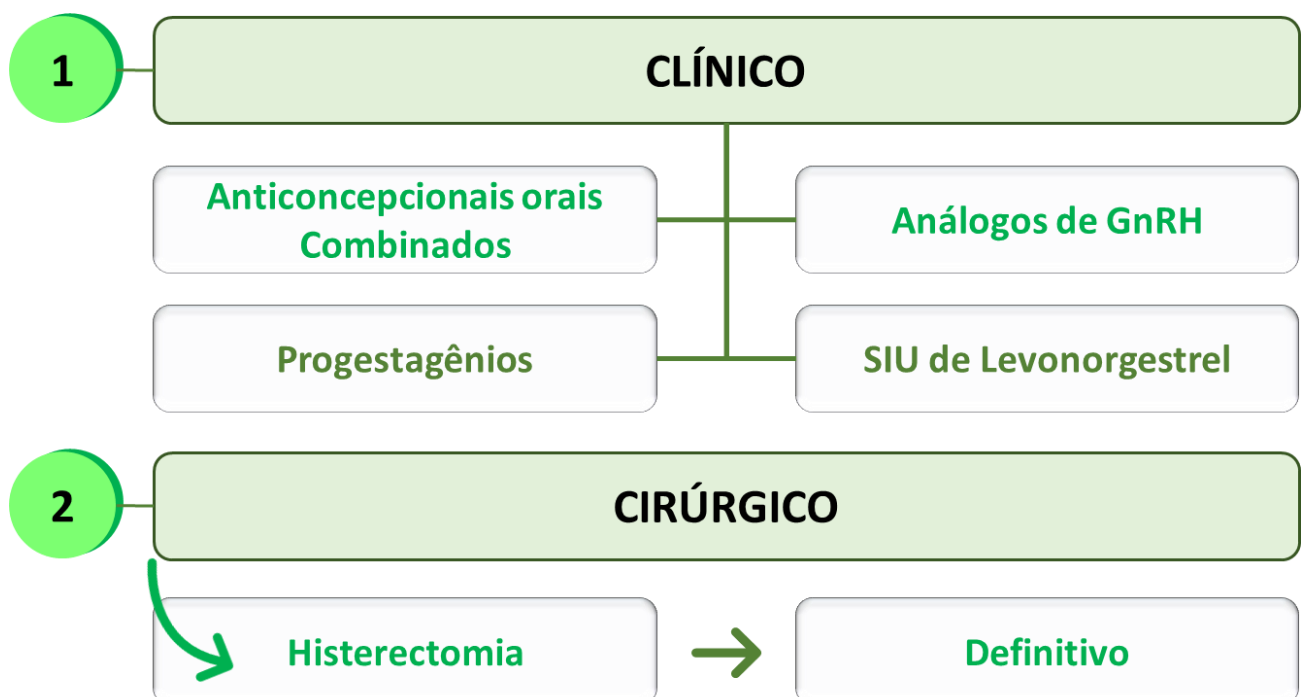


Vou Gabaritar na Residência

3. (ENARE 2025 R4 GO) – Uma paciente de 42 anos, gesta 2 para 2 (2 partos cesáreos), chega à consulta referindo aumento do sangramento e cólicas no período menstrual. Não faz uso de método contraceptivo. Rotina laboratorial aponta anemia. A ultrassonografia transvaginal evidencia assimetria de paredes uterinas, cistos miometriais e linhas de sombra acústica posterior. Frente à situação descrita, deve-se considerar a hipótese de:

- A. Sangramento uterino disfuncional.
- B. Mioma intramural.
- C. Endometriose peritoneal.
- D. Adenomiose.
- E. Achados típicos da quarta década de vida.

8.5 TRATAMENTO





Desmistificando a Farmacologia

▪ ANÁLOGOS DE GNRH

Fármacos que se conectam aos receptores de GnRH

Simula uma menopausa

1ª fase ("Flare up"):
7-14 dias de duração, aumenta a ação do GnRH

Efeitos colaterais: fogachos, secura vaginal, alterações emocionais, perda de massa óssea

2ª fase ("Down regulation"):
bloqueio da ação do GnRH (da liberação do FSH/LH)

Cautela no uso > 6 meses

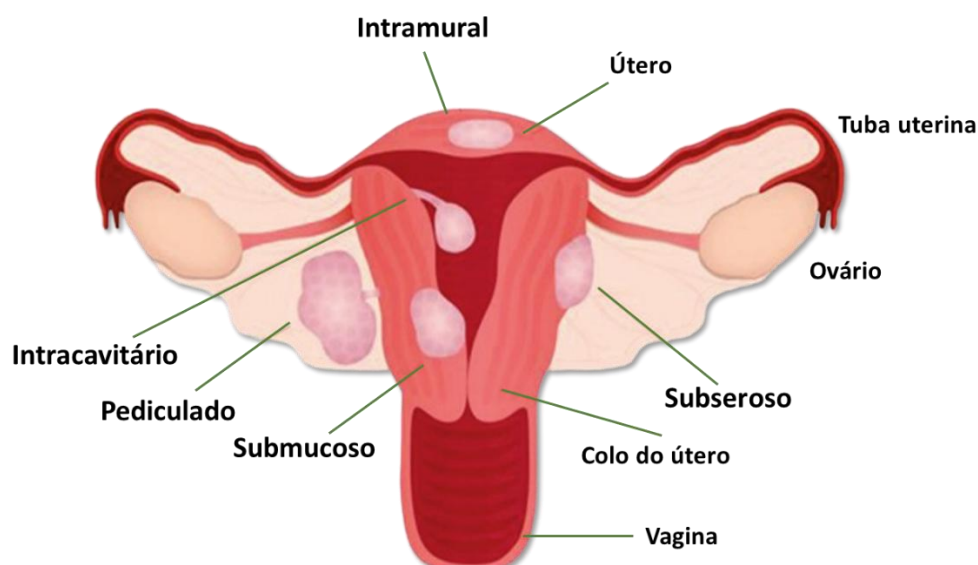
Tipos de Análogos

- Acetato de nafarelina spray intranasal, usado a cada 12 horas;
- Acetato de gosserelina, subcutâneo, a cada 28-90 dias;
- Acetato de leuprolida, intramuscular, a cada 28-90 dias

CAUSAS ESTRUTURAIS LEIOMIOMATOSE

9 CAUSAS ESTRUTURAIS

9.1 LEIOMIOMATOSE



<https://www.casavitta.com.br/hospital/novidade/mioma-uterino-oque-e-e-quais-as-formas-de-tratamento.html>



10 LEIOMIOMATOSE

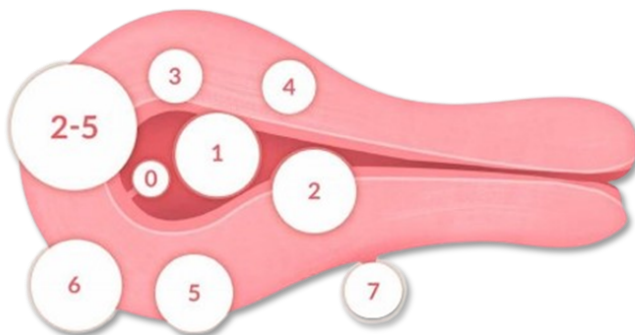
FATORES DE RISCO

- Idade > 30 anos
- Raça Negra
- Obesidade
- História familiar

FATORES DE PROTEÇÃO

- Paridade
- Anticoncepcionais Combinados Orais
- Tabagismo

Classificação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia - FIGO



<https://ipgo.com.br/miomas-uterinos-e-a-infertilidade-classificacao-anatomica/>

0	Intracavitário, pediculado
1	Submucoso, < 50% intramural
2	Submucoso, ≥ 50% intramural
3	Intramural, tangenciando o endométrio
4	Intramural
5	Subseroso, ≥ 50% intramural
6	Subseroso, < 50% intramural
7	Subseroso, pediculado
8	Outros (ex: cervical, parasita)



10.1 CLÍNICA

Assintomáticas

Sintomas gastrointestinais

Sangramento aumentado na menstruação e intermenstrual

Dor pélvica acíclica

Dismenorreia secundária

Dispareunia

Sintomas compressivos

Infertilidade

Sintomas urinários

Abortamento, TPP, CIUR e Apresentação anômala

O MIOMA

Tumor composto por fibras de musculatura lisa entrelaçadas por tecido conectivo

DEGENERAÇÕES

Hialina

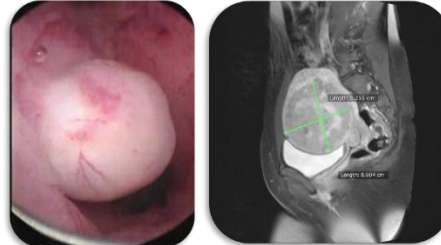
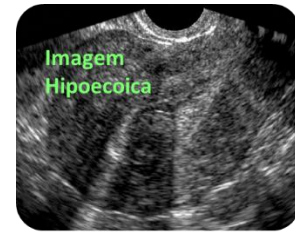
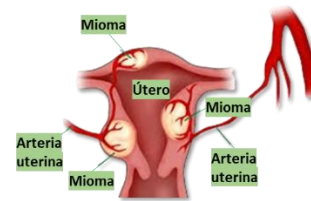
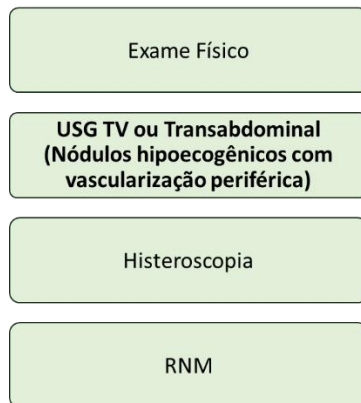
Rubra/Vermelha/Necrobiose asséptica (Gestante)

Gordurosa

Calcificação

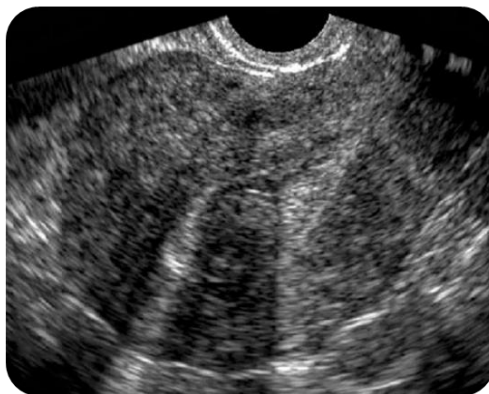
Cística

Sarcomatosa



<https://www.intervirradiologia.com.br/caso-clinico-embolizacao-de-mioma-uterino/>
<http://www.videohisteroscopia.net/site/home.php?funcao=mioma>
<https://lifestyle.sapo.pt/saude/saude-e-medicina/artigos/qual-o-impacto-dos-miomas-uterinos-na-vida-sexual-das-mulheres>

ULTRASSOM

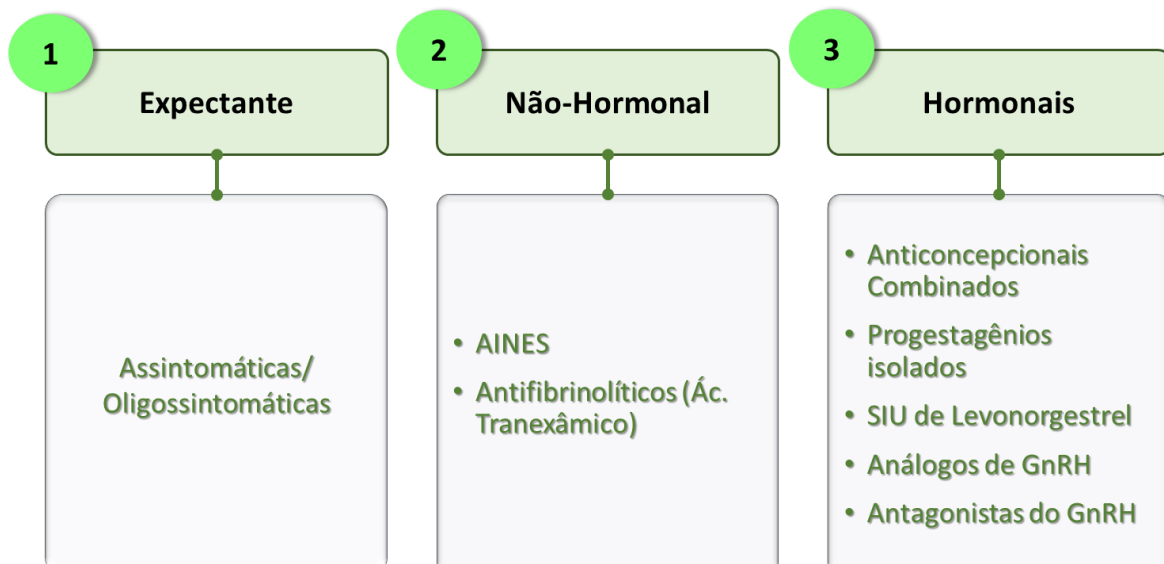


HISTEROSSONOGRAFIA



<https://www.cetrus.com.br/aluno-artigos/a-contribuicao-da-ultrassonografia-no-diagnostico-do-mioma-uterino>

10.2 TRATAMENTO





10.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO

1

MIOMECTOMIA

Histeroscópica
(FIGO 0, 1 e 2)

Laparoscópica/ Robótica/Aberta

11 MIOMECTOMIA HISTEROSCÓPICA

11.1 LASMAR

	Penetração	Tamanho	Base	Terço	Parede lateral
0	0	= 2cm	= 1/3	Inferior	+1
1	= 50%	> 2 a 5cm	> 1/3 a 2/3	Médio	+1
2	> 50%	> 5cm	> 2/3	Superior	+1
Escore	+	+	+	+	=



Escore	Grupo	Conduta sugerida
0 a 4	I	Miomectomia histeroscópica com baixa complexidade
5 e 6	II	Miomectomia complexa, pensar em preparo com análogo do GnRH e/ou cirurgia em 2 tempos
7 a 9	III	Indicar outra técnica não histeroscópica

Miomas Submucosos: Classificação Pré-Operatória para Avaliação da Viabilidade da Cirurgia Histeroscópica; RBGO - v. 26, no 4, 2004



12 LEIOMIOMATOSE

12.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO

1

MIOMECTOMIA

Histeroscópica
(FIGO 0, 1 e 2)

Laparoscópica/
Robótica/Aberta



<http://www.grupoizi.com.br/2012/01/embolizacao-de-mioma-uterina.html>

2

HISTERECTOMIA

Total X Subtotal

Laparoscópica/
Robótica/Aberta

Vaginal

3

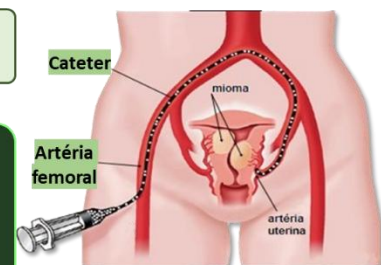
EMBOLIZAÇÃO DAS ARTÉRIAS UTERINAS

Tratamento conservador

Contraindicações:
Miomas FIGO 0 e 7,
coagulopatias, DRC, uso de
anticoagulantes e gravidez

Radiointervencionista

Complicações:
Dor abdominal, endometrite,
febre, amenorreia e FOP



<http://www.grupoizi.com.br/2012/01/embolizacao-de-mioma-uterina.html>



Vou Gabaritar na Residência

4. (SUS-BA 2025 ACESSO DIRETO) – Uma paciente de 36 anos de idade, tentando engravidar, sem histórico de doenças ginecológicas relevantes, queixa-se de menstruação abundante e dor pélvica intermitente. Ao exame físico, o útero está aumentado e sensível. Uma ultrassonografia transvaginal revela a presença de um leiomioma intramural de classificação FIGO 3, de 5cm, localizado na parede posterior do útero, com características sugestivas de degeneração. A paciente está interessada em discutir opções de tratamento, já que deseja manter a fertilidade. De acordo com a classificação FIGO - Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia - para leiomiomas uterinos, o termo FIGO 3, atribuída ao leiomioma desta paciente, significa:

- A. O leiomioma está localizado inteiramente na camada subserosa do útero.
- B. O leiomioma é submucoso, com mais de 50% do volume invadindo a cavidade uterina.
- C. O leiomioma é intramural, sem contato com o endométrio.
- D. O leiomioma é intramural, em contato com o endométrio, mas sem invadir a cavidade uterina.

SUA PÓS-MENOPAUSA

13 SUA PÓS-MENOPAUSA

“Qualquer sangramento uterino na pós-menopausa”

CAUSAS

Atrofia genital

Pólipo

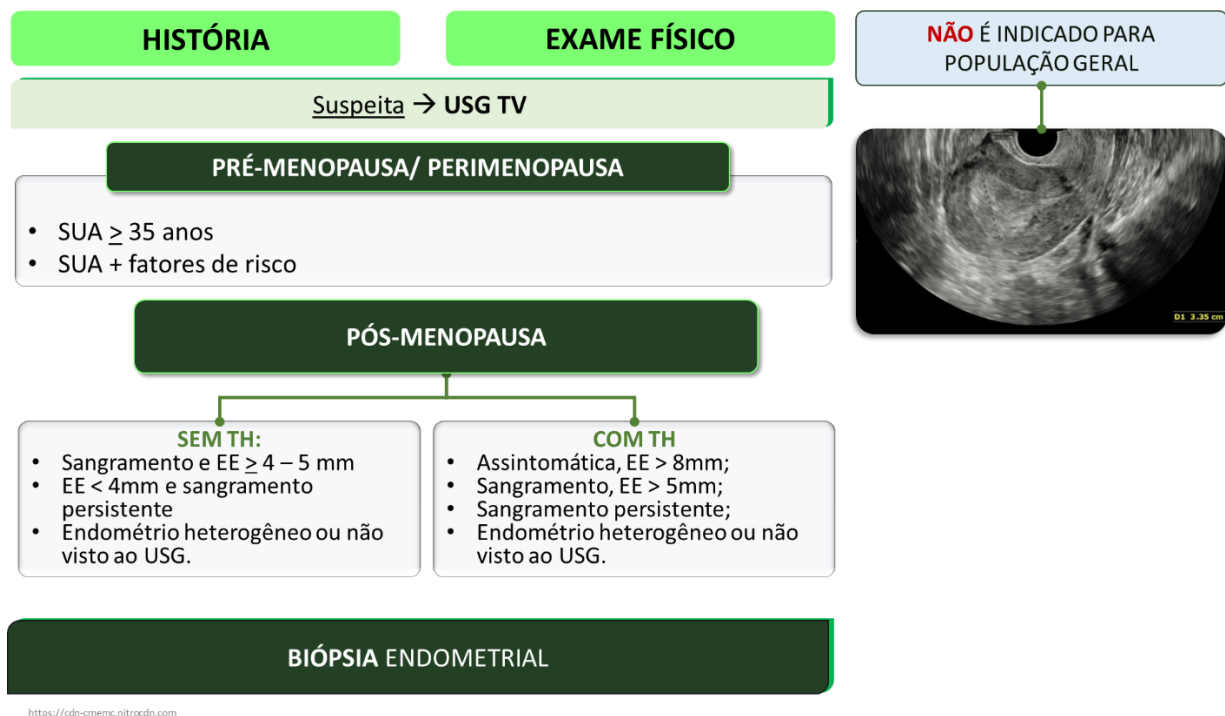
Terapia de reposição hormonal

Hiperplasia endometrial

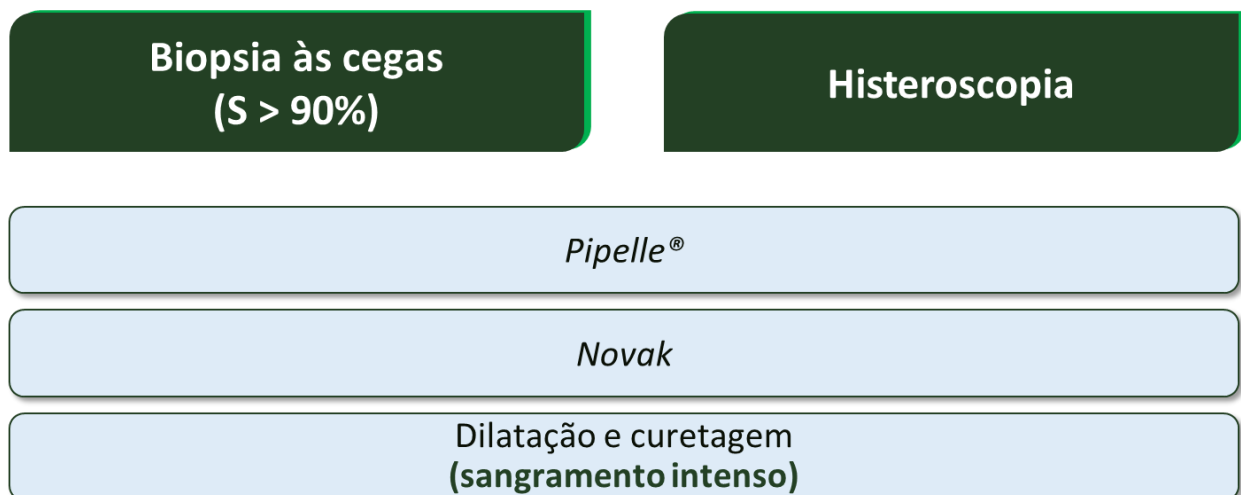
Câncer de endométrio - 6-19%

EXCLUIR MALIGNIDADE

“NÃO há exames para rastreamento para o câncer de endométrio na população de risco habitual”



14 BIÓPSIA ENDOMETRIAL



https://images.tcdn.com.br/img_prod/780820/cureta_de_novak_23_5_cm_para_biopsia_uterina_5630698_1_20200529195851.jpg
https://io.wp.com/www.endotherapeutics.com.au/wp-content/uploads/Pipelle-Endometrial-Sampling_Hero.jpg?fr=800%2C600&ssl=1



HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

15 HIPERPLASIA ENDOMETRIAIS

15.1 OMS 2014

5%

Hiperplasia sem atipia

28%

Hiperplasia atípica/ Neoplasia intraepitelial endometrial

HIPERPLASIA COM ATIPIA

**Lesão precursora ou
marcador de câncer de
endométrio concomitante**

**Quando suspeitar de
hiperplasia endometrial?**

- Sangramento uterino anormal (perimenopausa/pós-menopausa)
- AGUS ou células endometriais na citologia oncológica

DIAGNÓSTICO



Biópsia endometrial

TRATAMENTO

HIPERPLASIA COM ATIPIA

Progesterona (prole não definida)

Histerectomia
+ Salpingectomia bilateral
(pós-menopausa ou prole definida)

HIPERPLASIA SEM ATIPIA

Expectante

Progesterona

HISTERECTOMIA

- DIU de Levonorgestrel
- Orais

- Progressão para atipia + Prole definida
- Sem regressão após 12 meses de tratamento
- Recidiva da hiperplasia após o término do tratamento
- SUA persistente
- **NÃO** deseja/ **NÃO** adere o tratamento clínico



Doutorando EMR

▪ HIPERPLASIA ENDOMETRIAL/CÂNCER DE ENDOMÉTRIO

FATORES DE RISCO

Idade mais avançada (50-70 anos)

SOP

Uso de estrogênio sem
oposição da progesterona

Obesidade

Uso de tamoxifeno

DM/HASC

Menarca precoce

Tumor produtor de estrogênio

Menopausa tardia

Síndrome de Lynch

Nuliparidade

Síndrome de Cowden

História familiar de câncer de endométrio, ovário, mama e colón



Vou Gabaritar na Residência

5. (HOS-SP 2025 ACESSO DIRETO) – Entre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta a principal causa de sangramento uterino pós-menopausa.

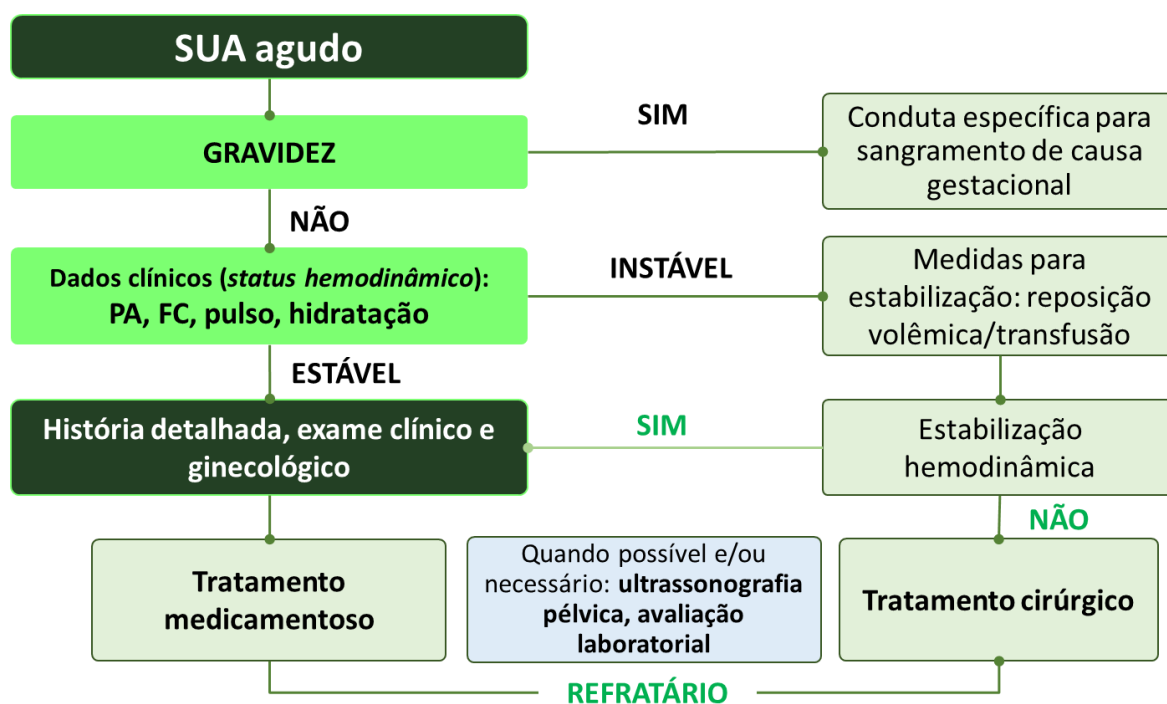
- A. Pólipo endometrial.
- B. Cisto ovariano.
- C. Uso de tamoxifeno.
- D. Mioma submucoso.
- E. Atrofia endometrial.



MANEJO DO SANGRAMENTO ANORMAL AGUDO NA URGÊNCIA

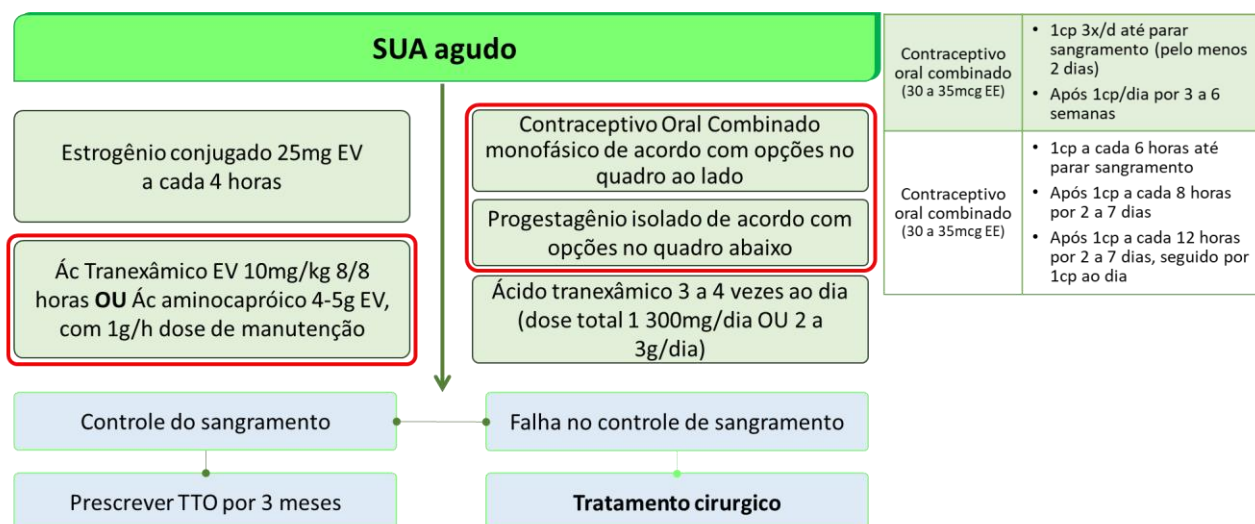
16 MANEJO DO SANGRAMENTO

16.1 URGÊNCIA

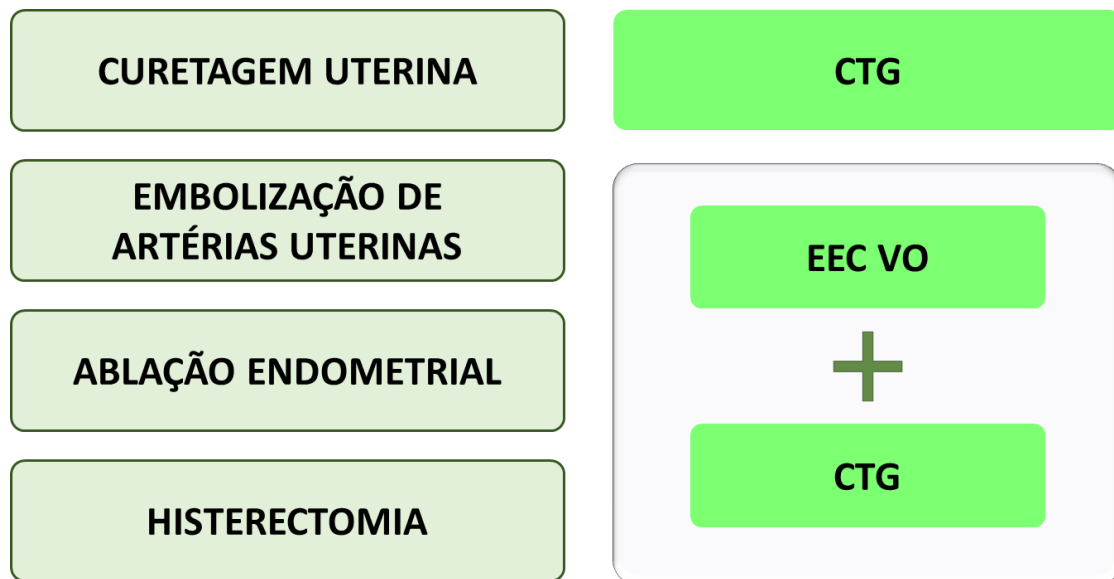


Adaptado de: <https://www.febrasgo.org.br/images/pec/Protocolos-assistenciais/Protocolos-assistenciais-ginecologia.pdf/Sangramento-uterino-anormal.pdf>

16.2 URGÊNCIA – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO



Adaptado de: <https://www.febrasgo.org.br/images/pec/Protocolos-assistenciais/Protocolos-assistenciais-ginecologia.pdf/Sangramento-uterino-anormal.pdf>



Adaptado de: <https://www.febrasgo.org.br/images/pec/Protocolos-assistenciais/Protocolos-assistenciais-ginecologia.pdf/Sangramento-uterino-anormal.pdf>

? Caso Clínico

- Adriana, 36 anos, G2P2 (PN), procurou ajuda no posto de saúde porque a sua menstruação está muito intensa e com muitas cólicas há 3 anos. Refere que antes ficava 4 dias menstruada e que hoje chega a ficar 15 dias e precisa usar fralda, às vezes. Relata também que está achando a sua barriga maior. Ao exame físico, vulva sem alterações, colo e vagina também sem alterações. O toque vaginal evidenciou um colo ginecológico, móvel e indolor e um útero palpável 5 cm acima da sínfise púbica, de consistência endurecida, superfície irregular e móvel.
- Dentro do mnemônico PALM-COEIN, a provável causa da SUA de Maria José é estrutural ou não-estrutural?
Como há alteração importante ao exame físico, a causa do SUA é estrutural.
- Qual o primeiro exame que devemos solicitar para iniciar a investigação da causa da SUA em Maria José?
Iniciamos a investigação pelo ultrassom transvaginal com complementação abdominal, quando necessário.
- Sendo a causa estrutural a mais provável, qual é a principal hipótese de diagnóstico?
Devido ao exame físico e a epidemiologia, a principal hipótese é a leiomiomatose.





Gabarito:

1.	E
2.	C
3.	D
4.	D
5.	E

A EMPRESA



EMR – Eu Médico Residente Ensino Ltda ©

Todos os direitos reservados.

CNPJ: 34.730.954/0001-71

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das edições criadas pelo **Eu Médico Residente ©**. A violação dos direitos autorais dessa obra caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.



[instagram.com/eumedicoresidente/](https://www.instagram.com/eumedicoresidente/)



[YouTube/eumedicoresidente](https://www.youtube.com/eumedicoresidente)



contato@eumedicoresidente.com.br



www.eumedicoresidente.com.br



EMR – Eu Médico Residente ©

Todos os direitos reservados

www.eumedicoresidente.com.br